GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

Reconocimiento y manejo inicial de la sepsis en el Servicio de Urgencias

Ricardo Villalba; María José Benítez

Servicio de Urgencias y Unidad de Terapia Intensiva — Hospital General de Itapúa

Mayo de 2026 — Versión de prueba 0.1

DOCUMENTO DE PRUEBA — Contenido ficticio elaborado con fines académicos para validar el Repositorio Digital del Hospital General de Itapúa. Los autores, datos y resultados son simulados.

Advertencia

Esta guía es un DOCUMENTO DE PRUEBA creado para validar el repositorio. Resume conceptos generales y NO debe utilizarse para tomar decisiones clínicas. Para la atención de pacientes deben seguirse los protocolos institucionales vigentes.

Alcance y población

Dirigida al personal médico y de enfermería del Servicio de Urgencias. Población: pacientes adultos con sospecha de infección y signos de disfunción orgánica.

Reconocimiento temprano

Aplicar una herramienta de tamizaje validada en el triaje a todo paciente con sospecha de infección. Valorar signos vitales, estado de conciencia, perfusión periférica y diuresis. Ante sospecha de sepsis, activar el circuito de atención prioritaria.

Evaluación inicial

Solicitar estudios de laboratorio según protocolo, incluyendo lactato cuando esté disponible. Obtener muestras para cultivo antes de iniciar antimicrobianos, siempre que ello no retrase el tratamiento. Buscar el foco infeccioso.

Tratamiento inicial

Iniciar tratamiento antimicrobiano empírico de forma precoz, según el protocolo institucional y el foco sospechado. Indicar reanimación hemodinámica guiada por la evaluación clínica. Considerar soporte vasopresor e interconsulta con la Unidad de Terapia Intensiva ante hipotensión persistente.

Reevaluación y seguimiento

Reevaluar al paciente de forma frecuente durante las primeras horas: respuesta hemodinámica, perfusión, diuresis y evolución de los parámetros de laboratorio. Ajustar el tratamiento según los resultados de los cultivos y documentar todas las intervenciones.

Indicadores sugeridos

Proporción de pacientes con tamizaje en el triaje; tiempo hasta la primera dosis de antimicrobiano; proporción de pacientes con cultivos tomados antes del tratamiento.